Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Esta pauta –de uso optativo- ha sido diseñada para facilitar a los profesionales que realizan los procesos de evaluación de NEE, en el marco del Decreto 170, la recogida de antecedentes de anamnesis relevantes del estudiante. Puede ser completada por uno o más profesionales en el proceso de detección y evaluación de las NEE que presenta el alumno (a) y de los apoyos que requiere para aprender y participar en el contexto escolar.

1. DENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre	Fridora Leonor Espud Mejías.			Sexo	F	✓	M
Fecha Nacimiento	27/Dic/2017	Edad actual	6 años 3 meses	País natal:	Chile		
Domicilio actual:	Pascual Baburiza # 1334.			Teléfono	978029900		
Lengua materna	Español	Grado dominio	comprende ☒ habla ☒ lee ☒ escribe ☒				
Lengua de uso	Español	Grado dominio	comprende ☒ habla ☒ lee ☒ escribe ☒				
Escolaridad actual:	1° B.	Establecimiento	**Liceo Mixto Los Andes Básico N°1**				

2. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS INFORMANTES

1. Fecha de la entrevista: 27-03-24	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Nathaly Mujica	Nombre:
Relación con el/la estudiante: Madre	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):
3. Fecha de la entrevista:	4. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Relación con el/la estudiante:	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):

3. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS ENTREVISTADORES

1. Fecha de la entrevista: 27-03-24.	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Pablo Rio Flores.	Nombre:
Rol/cargo: Ed. Diferencial.	Rol/cargo:
3. Fecha de la entrevista:	3. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Rol/cargo:	Rol/cargo:

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN QUE MOTIVA LA ENTREVISTA

Ingreso a Programa de Integración Escolar.

5. ANTECEDENTES RELATIVOS AL DESARROLLO Y A LA SALUD DEL/LA ESTUDIANTE

¿El o la estudiante tiene algún diagnóstico previo? ☐ No ☒ Sí **(especificar)**

Pediatría:	Psicología:
Kinesiología:	Psiquiatría:

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LE

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Genético:	Psicopedagogía:
Fonoaudiología: TEL EXPRESIVO (3 años)	Terapia Ocupacional:
Neurología:	Otro:

5.1. Primer año de vida

Tipo de parto: ☐ normal ☐ inducido ☐ fórceps ☑ cesárea (señalar motivo) prog no madó | Peso: 2,800 | Talla: 40,

¿Tuvo asistencia médica durante el parto? ☑ SI ☐ NO

Señale antecedentes relevantes del Embarazo y Parto:

- Presentó tinto mes de pérdida durante todo el embarazo.

Señale si durante los doce primeros meses de vida el niño o niña presentó:

Desnutrición	Sí	~~No~~	Traumatismos	Sí	~~No~~	Encefalitis	Sí	~~No~~
Obesidad	Sí	~~No~~	Intoxicación	~~Sí~~	No	Meningitis	Sí	~~No~~
Fiebre alta	~~Sí~~	No	Enfermedad respiratoria	Sí	~~No~~	Otra(s)		
Convulsiones	Sí	~~No~~	Asma	Sí	No			
Hospitalizaciones	Sí	No ✓	Especifique motivos y duración:					

Se realizaron controles periódicos de salud	~~Sí~~	No	Vacunas	~~Sí~~	No

Observaciones:

- Alergia alimentaria
- Alérgica a mariscos, pescado y maní.

5.2. Desarrollo Sensorio Motriz

Edad en que el niño (a)

Fija la cabeza: 3 m.	Se sienta sólo/a: 6-7 m.	Camina sin apoyo: 1 a
Primeras palabras: 1,2 a	Primeras frases: 2 a	Se viste solo/a: 3 a.

Controla esfínter vesical Diurno: ✓ Nocturno: ✓	Controla esfínter anal Diurno: ✓ Nocturno: ✓

Observaciones:

sin observaciones.

En su actividad motora general se aprecia:
☐ normal ☑ activo ☐ hiperactivo ☐ hipoactivo

Su tono muscular general se aprecia:
☑ normal ☐ hipertónico ☐ hipotónico

En relación con su motricidad gruesa se aprecia:

Estabilidad al caminar	~~Sí~~	No	Caídas frecuentes	~~Sí~~	No	Dominancia lateral	Sí	No

En relación con su motricidad fina el niño (a) logra:

Garra	~~Sí~~	No	Prensión	~~Sí~~	No	Pinza	~~Sí~~	No
Ensarta	~~Sí~~	No	Dibuja	~~Sí~~	No	Escribe	~~Sí~~	No

En relación con algunos signos cognitivos el niño (a)

Reacciona a voces o caras familiares	~~Sí~~	No	Manipula y Explora objetos	~~Sí~~	No
Demanda objetos y compañía	~~Sí~~	No	Comprende prohibiciones	~~Sí~~	No
Sonríe, balbucea, grita, llora, indica o señala	~~Sí~~	No	Posee evidente descoordinación ojo-mano	Sí	~~No~~

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIAL

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Observaciones:

Sin observaciones relevantes.

5.3. Visión - Audición:					
Se interesa por los estímulos visuales (colores, formas, movimientos, etc.)	Sí ✓	No	Se interesa por los estímulos auditivos (ruidos, voces, música, etc.)	Sí ✓	No
En ocasiones tiene los ojos irritados o llorosos	Sí	No ✓	Reacciona o reconoce voces o sonidos familiares	Sí ✓	No
Presenta dolores frecuentes de cabeza	Sí ✓	No	Gira la cabeza cuando se le llama o ante un ruido fuerte	Sí	No ✓
Se acerca o aleja demasiado los objetos a la vista (frunce el ceño)	Sí	No ✓	Acerca los oídos a la TV, radio o fuente de sonido.	Sí	No ✓
Sigue con la vista el desplazamiento de los objetos o personas	Sí ✓	No	En ocasiones se tapa o golpea los oídos	Sí	No ✓
Presenta movimientos oculares "anormales"	Sí	No ✓	Presenta frecuentes dolores de oídos	Sí	No ✓
Manifiesta conductas "erróneas" (tropiezos, choques)	Sí	No ✓	La pronunciación oral es adecuada	Sí	No ✓
Presenta diagnóstico médico de miopía, estrabismo, astigmatismo, u otro.	Sí	No ✓	Presenta diagnóstico médico de otitis crónica, hipoacusia u otra.	Sí	No ✓

Observaciones:

Sin observaciones.

5.4. Desarrollo del Lenguaje

El niño (a) se comunica preferentemente en forma

☐ oral ☐ gestual ☑ mixto ☐ otro (especifique):

Características del lenguaje expresivo					
Balbucea (oral o señas)/emite sonidos	Sí ✓	No	Emite/produce frases	Sí ✓	No
Vocaliza/realiza gestos o señas aisladas	Sí	No ✓	Relata experiencias	Sí	No ✓
Emite palabras/produce señas	Sí ✓	No	La emisión/pronunciación/producción es clara	Sí	No ✓
Características del lenguaje comprensivo					
Identifica objetos	Sí ✓	No	Sigue instrucciones simples	Sí ✓	No
Identifica personas	Sí ✓	No	Sigue instrucciones complejas	Sí ✓	No
Comprende conceptos abstractos	Sí ✓	No	Sigue instrucciones grupales	Sí ✓	No
Responde en forma coherente preguntas de la vida diaria	Sí ✓	No	Comprende relatos, noticias, cuentos cortos	Sí ✓	No

Manifestó pérdida del lenguaje oral (especifique edad y motivos): Sí, a los 3 años. diagnóstico trastorno del lenguaje TEL Expresivo.

Observaciones:

Asistió a escuela de lenguaje.

5.5. Desarrollo Social

Se relaciona espontáneamente con las personas de su entorno natural.	Sí ✓	No	Se relaciona en forma colaborativa	Sí ✓	No
Explica razones de sus comportamientos y actitudes	Sí ✓	No	Respeta normas sociales	Sí ✓	No
Participa en actividades grupales	Sí ✓	No	Respeta normas escolares	Sí ✓	No

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR L
A LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Opta por trabajo individual	Sí	No	Muestra sentido del humor	Sí	No
Presenta lenguaje ecolálico (repite palabras, silabas, etc.)	Sí	No	Movimientos estereotipados (repetitivos)	Sí	No
Exhibe dificultad para adaptarse a situaciones nuevas	Sí	No	Pataletas frecuentes	Sí	No

Ante los siguientes estímulos su reacción es:

Luces: ☑ natural ☐ desmesurada

Sonidos: ☑ natural ☐ desmesurada

Personas extrañas: ☑ natural ☐ desmesurada

Observaciones:

Sin observaciones.

5.6. Estado Actual de Salud del/la Estudiante					
Vacunas al día	Sí	No	Trastorno motor	Sí	No
Epilepsia	Sí	No	Problema bronco-respiratorio	Sí	No
Problemas cardiacos	Sí	No	Enfermedad infecto-contagiosa	Sí	No
Paraplejia	Sí	No	Trastorno emocional	Sí	No
Pérdida auditiva	Sí	No	Trastorno conductual		
Pérdida visual	Sí	No	Otro (especifique):		

El o los problemas de salud reciben control/tratamiento (especifique): —

Alimentación: ☐ normal ☑ "malo/a" para comer ☐ "bueno/a" para comer ☐ Otro (especifique)

Peso (apreciación del informante): ☐ normal ☑ bajo peso ☐ obesidad

Sueño: ☑ normal ☐ tranquilo ☐ inquieto Horas que duerme: 9 hrs.

☐ insomnio ☐ pesadillas ☐ terrores nocturnos ☐ sonambulismo ☐ despierta de buen humor

Duerme: ☑ solo ☐ acompañado (Especifique):

Humor/comportamiento *(señale el comportamiento habitual)*

☑ alegre ☑ juguetón/bromista ☑ risueño(a) ☐ triste ☐ serio ☐ rebelde ☐ apático ☐ violento(a)

Otro:

Observaciones: no es muy bueno para comer, debido a su alergia alimentaria.

6. ANTECEDENTES FAMILIARES

Personas que viven con el niño o niña y/o que son que son responsables de su cuidado.

Nombre	Parentesco	Edad	Escolaridad	Ocupación actual
1. Nathaly Mejías	madre	33	—	trabaja y estudia
2. Kristna C. Mejías	hermana	16	—	estudiante
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Antecedentes de Salud de la Familia
*(Señale aquellos **antecedentes que son relevantes en función de la entrega de apoyos que requiere** el o la estudiante):*
-> Abuela materno. padre: diabetes.
Observaciones:
Sin observaciones relevantes.

7. ANTECEDENTES ESCOLARES Y APOYO DE LA FAMILIA

Trayectoria escolar					
Edad de ingreso al sistema escolar	3.	Asistió a jardín infantil		Sí ☑	No
N° de colegios en que ha estudiado	2	Modalidad de enseñanza Regular ☑ Especial ☑ Técnica ☐:			
Motivo de los cambios: pasa a 1º básico.					
Ha repetido curso/s	Sí	No ✓	Curso(s)	Motivo:	

Situación actual											
Nivel/curso actual	1º B.		**Dificultad de aprendizaje**	Sí	No ✓	**Dificultad para participar**	Sí	No ✓	**Conducta disruptiva**	Sí	No ✓
Asiste regularmente	Sí ✓	No	**Asiste con agrado**	Sí ✓	No	**Apoyo familiar en tareas**	Sí ✓	No	**Amigos (as)**	Sí ✓	No

Actitud de la familia

¿Cómo evalúa la familia el desempeño escolar del estudiante?
☑ satisfactorio ☐ insatisfactorio (motivos) .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a las dificultades escolares del estudiante?
☑ apoyo ☐ castigo ☐ indiferencia ☐ compasión ☐ tensión ☐ otra .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a los éxitos escolares del estudiante?
☑ apoyo ☐ indiferencia ☐ otra .....
Especifique el tipo de refuerzos o premios:
☑ expresiones afectivas ☑ alimentos preferidos ☑ ver TV ☑ juguetes ☐ tiempo libre ☐ otro(s).....

¿Quiénes apoyan el proceso de aprendizaje y desarrollo del estudiante?
☑ madre ☐ padre ☑ hermanos/as ☑ Otros familiares ☐ Otros profesionales .....

¿Qué expectativas muestra la familia frente al futuro escolar del estudiante?
☑ alta (incluye al grupo familiar) ☐ mediana (incluye sólo madre/padre) ☐ baja (no incluye a ningún miembro)

¿Ofrece la familia un ambiente físico y emocional adecuado para el aprendizaje?
☑ Ambos ☐ Sólo físico (espacios, materiales, ventilación, luminosidad) ☐ Sólo emocional (tranquilo, relajado, comprensivo)

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

8. INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE EN EL ESTABLCIMIENTO

Permanencia

*(Señale aquellos **antecedentes en relación a la permanencia** del estudiante en el establecimiento, por ejemplo, se traslada de una ciudad a otra de manera constante, tiene considerado retirarlo del establecimiento antes que termine el año, etc.):*

- Por no renovio de matricula de nuevo el 2024.

Comentarios u otras observaciones relevantes que no se han registrado o explorado:

- Padre con orden de alejamiento hacia madre.
- Apoderado suplente, abuelo materno.
- Madre y hermana fueron dadas de alta del PPF la diciembre del 2023.
- El establecimiento educacional no está informado sobre los alergias alimentarias de Ysidora.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES